

Indywidualny *nie pojedyncza* modalność

ISTSS (2019) zaleca fazowy, spersonalizowany plan, nie pojedynczą terapię. Faza 1 stabilizacja, Faza 2 modalność, Faza 3 integracja. Razem: 2–5 lat.

CZAS: 15 min planowania z terapeutą **REALIZACJA:** po wstępnej ocenie, z okresowym przeglądem

ŹRÓDŁO: ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*); Herman (1992, model trójfazowy); Cloitre i in. (2012, RCT); Cloitre i in. (2018, ITQ); Carlson & Putnam (1993, DES-II)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **ocena wstępna:** narzędzia diagnostyczne (ITQ, DES-II, PHQ-9, ocena suicydalności), wywiad traumy (ACEs), zasoby i bariery. W sekcji 02 — **trzy fazy** z konkretnymi modalnościami. Sekcja 03 — **twój wstępny plan:** ocena, cele, modalność. Sekcja 04 — monitorowanie i przegląd.

DLACZEGO TO DZIAŁA

ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*) dla C-PTSD rekomenduje **fazowy, spersonalizowany** plan, *nie* pojedynczą modalność. Plan obejmuje trzy fazy z konkretnymi celami i modalnościami dopasowanymi do *pacjenta i fazy*. **Ocena wstępna:** (1) Narzędzia diagnostyczne — ITQ (Cloitre i in., 2018, różnicowanie PTSD/C-PTSD); DES-II (Carlson & Putnam, 1993, ocena dysocjacji); BDI-II lub PHQ-9 (depresja); ocena suicydalności; ECR (przywiązanie); YSQ-3 (schematy Young). (2) Wywiad traumy — ACEs, typ i czas trwania, poprzednie terapie. (3) Zasoby i bariery — sieć wsparcia, sytuacja życiowa, motywacja, oporność na ujawnienie. **Faza 1 — STABILIZACJA** (3–24 miesiące): protokół według ISTSS (2019). Cel: pacjent funkcjonuje w oknie tolerancji przez większość czasu; ma 3–5 sprawdzonych technik regulacyjnych; brak aktywnych zachowań autodestrukcyjnych. Modalności: STAIR (Cloitre), umiejętności DBT (jeśli silna dysregulacja), praca somatyczna, CFT. Farmakoterapia wspomagająca: SSRI (sertralina, escitalopram), prazosyna na koszmary. **Faza 2 — PRZETWARZANIE** (12+ miesięcy): wybór metody dostosowany do pacjenta: EMDR (z modyfikacjami dla dysocjacji); STAIR + NST; Schema Therapy; IFS; *imagery rescripting*; Sensorimotor Psychotherapy; CPT lub PE adaptowane. Tempo: „dłużej niż myślisz, wolniej niż chciałbyś” (Cloitre). **Faza 3 — INTEGRACJA** (miesiące do lat): zamknięcie niedokończonych spraw, budowanie tożsamości po-traumatycznej, relacji, sensu, wartości. Niekiedy postraumatyczny wzrost (PTG) — jako możliwość, nie cel. **Monitorowanie:** PCL-5 lub ITQ co 6–8 tygodni; regularna superwizja dla terapeuty (ryzyko traumatyzacji wtórnej). **Klinicznie:** terapeuta jednej modalności (np. tylko CBT) próbuje C-PTSD. Po roku pacjent ma częściową poprawę, ale nadal dysocjuje, ma problemy relacyjne i somatyczne. Bez elastyczności modalitetowej i fazowości plan jest niewystarczający. Rozwiązanie: indywidualny plan — ocena ITQ, ACEs, DES-II, ECR, schematy → wybór modalności per faza i pacjent. Faza 1: STAIR + somatyczne (lub DBT, jeśli silna dysregulacja); Faza 2: EMDR (jeśli pojedyncze wspomnienia dominują) lub IFS (jeśli fragmentacja części) lub Schema (jeśli komorbidne zaburzenie osobowości); Faza 3: terapia relacyjna, grupa, integracja. Co 3 miesiące przegląd planu.

01 Ocena wstępna — fundament planu

A · NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

ITQ (różnicowanie PTSD/C-PTSD), **DES-II** (dysocjacja), **PHQ-9** (depresja), ocena suicydalności, **ECR** (przywiązanie), **YSQ-3** (schematy).

B · WYWIAD TRAUMY

ACEs — bez szczegółów traumatycznych. Typ traumy, czas trwania, wiek, czy aktywna. Poprzednie terapie: co działało, co nie, dlaczego skończyły.

C · ZASOBY I BARIERY

Sieć wsparcia, sytuacja życiowa (mieszkanie, finanse, praca), motywacja, oporność na ujawnienie, dostępność farmakologii i terapeuty.

02 Trzy fazy — modalności dostosowane do pacjenta

FAZA	CEL + METRYKI	MODALNOŚCI (WYBÓR ZALEŻNY OD PACJENTA)
1 · Stabilizacja 3–24 mies.	Funkcjonowanie w oknie tolerancji, 3–5 strategii regulacji, brak autodestrukcji.	STAIR (Cloitre), umiejętności DBT , praca somatyczna , CFT . Farmakoterapia: SSRI, prazosyna.
2 · Przetwarzanie 12+ mies.	Spadek intruzji, integracja narracji, brak destabilizacji po sesjach.	EMDR (modyfikowane) lub STAIR + NST lub IFS lub Schema lub Sensorimotor ; <i>imagery rescripting</i> .
3 · Integracja miesiące–lata	Spójna narracja, satysfakcjonujące relacje, wartości jako kompas.	Terapia relacyjna, grupa wsparcia, praca z sensem (ACT, terapia egzystencjalna), niekiedy PTG jako możliwość.

03 Mój wstępny plan + monitorowanie

MOJA OBECNA FAZA I KONKRETNE CELE

— hipoteza: 1 / na pograniczu 1–2 / 2 / 3; 3 konkretne cele do uzgodnienia z terapeutą

WYBRANA MODALNOŚĆ DLA OBECNEJ FAZY

— STAIR / DBT / somatyczne / EMDR / IFS / Schema;
uzasadnienie wyboru z terapeutą

MOJE METRYKI MONITOROWANIA

— PCL-5 lub ITQ co 6–8 tyg.; konkretne dni z dobrym snem, długość okna tolerancji, liczba kryzysów

MÓJ ZESPÓŁ OPIEKI

— psychoterapeuta + psychiatra (jeśli leki) + grupa wsparcia / przyjaciele; kto z kim się komunikuje

Klucz: kompleksowy plan leczenia C-PTSD *nie* jest „jedną terapią od A do Z”. Jest *indywidualnym, fazowym, wielomodalnym* procesem trwającym 2–5 lat — czasem dłużej. Niektórzy pacjenci pozostają *głównie w Fazie 1* przez całą terapię — i to też jest sukces. Stabilizacja zmienia jakość życia: lepszy sen, mniejsza dysregulacja, bezpieczne relacje. Nie każdy pacjent musi przejść do bezpośredniego przetwarzania traumy, by terapia była wartościowa. Plan ISTSS (2019) jest *narzędziem klinicznym*, nie biurokracją — bez niego po roku terapeuta i klient mogą nie wiedzieć, co konkretnie poprawiło się, co nie, co dalej. Z planem — można wrócić do umowy. Tempo Cloitre: „*dłużej niż myślisz, wolniej niż chciałbyś*” — to *nie* wada, to bezpieczeństwo.

△ Plan ma być żywy. Co 3–6 miesięcy przegląd: co się sprawdza, co nie, czy modalność dla obecnej fazy pasuje. Zmiana modalności w trakcie terapii *nie* jest porażką — często jest dowodem dojrzałości terapeutycznej. Jeden terapeuta może prowadzić różne modalności w różnych fazach lub można pracować z różnymi specjalistami sekwencyjnie. Najgorsza opcja: trwanie w terapii, która *nie* działa, bo „wstyd zmienić”.